

第4場_試辦區域基礎資料

第 4 場參考資料 | 試辦區域遴選之基礎資料與城鄉分級定義（待議 #3） 整理：
2026-06-30（2026-07-18 併入城鄉分級定義、來源直接列出成為獨立檔） · 對
應第 3 章 §3.4 試辦區域遴選（第 4 場，2026-08-07 討論） 已抓數據以新北、桃
園為主；生育率為全國分縣市。數據僅供初步盤點，正式引用前建議再核。

一、本計畫取向（試辦區域以「可近性」為規劃依據）

本計畫核心目的為提升緊急事後避孕藥（ECP）之可近性，故試辦區域應以「可近性相關因素」為規劃依據，而非以都市化程度或地方創生等分類為主。據此：

- **主要依據：**各區之空間可近性（距婦產科距離、婦產科稀缺、藥局可補位）、時間可近性（夜間 / 假日門診）、需求（育齡女性 / 青少女人口、性暴力被害、非預期懷孕風險）。
- **官方分類中唯一直接相關者：**健保署「醫療資源不足地區」（本即以醫療可近性界定），可作偏鄉操作名單。
- **都市化程度（劉介宇 7 級） / 主計總處都會區 / 地方創生：**僅作背景脈絡參考，非遴選主軸；「一二三四級城市」不採用（無官方依據）。

二、城鄉分級與偏鄉定義（背景參考）

一句話結論

台灣無官方統一之「一 / 二 / 三 / 四級城市」制度；藥師於第 2 場所提「四級城市」實為其參與之疾管署抗生素風險評估計畫之內部分組（六都 vs 其餘），該分組原始依據查無公開來源。城鄉分層宜改採下列權威分類。

可採之權威分類（依用途擇一）

用途	建議採用	來源類型
城鄉梯度分層 / 多級比較	劉介宇、洪永泰等（2006）鄉鎮市區「都市化程度」7 級分類	學術
「都會 vs 偏鄉」二分之偏鄉名單（主）	健保署「醫療資源不足地區」名單（逐年公告、現行維護、與醫療可近性直接相關）	官方
偏鄉名單（交叉驗證）	國發會地方創生 134 鄉鎮 + 衛福部 IDS 山地離島名單	官方

重點定義

- **劉介宇 2006 都市化 7 級**（全台 359 鄉鎮市區，集群分析）：①高度都市化 ②中度都市化 ③新興市鎮 ④一般鄉鎮市區 ⑤高齡化市鎮 ⑥農業市鎮 ⑦偏遠鄉鎮。判定變項：人口密度、專科以上教育比率、65 歲以上比率、農業人口比率、每 10 萬人西醫師數。（含「西醫師數」，與醫療可近性高度相關，最適 ECP 議題）
- **主計總處 都會區定義**：都會區＝中心都市＋衛星市鎮、人口 ≥30 萬；大都會 ≥100 萬。原 5 大都會區：台北、桃園中壢、台中彰化、台南、高雄。惟其範圍劃定之「統計地區標準分類」已於 2010 停用、無持續維護名單 → 可引定義、不宜當現行官方名單。
- **教育部偏遠地區學校三級**（《偏遠地區學校教育發展條例》）：偏遠 / 特殊偏遠 / 極度偏遠；指標含交通、文化、生活機能、數位環境、社經（單位為「學校」非鄉鎮）。
- **衛福部 IDS 山地離島**：山地離島醫療給付效益提昇計畫，有官方適用鄉鎮名單。「無醫鄉」（西醫師 0）為醫師公會統計、非法定定義。

對城鄉分層之建議

- 城鄉分層以**劉介宇 7 級**為主軸（可簡併為都市 / 半都市 / 鄉村 / 偏遠）；偏鄉操作名單以**健保署醫療資源不足地區**為準，並與地方創生 / IDS 交叉。
- 偏鄉試辦點若同時落在「健保不足地區 ∩ 地方創生 / IDS」，代表性最強。

三、遴選所需之基礎資料清單（含取得狀態）

面向	指標	用途	取得狀態
需求人口	各區育齡女性（15—49）、青少年（15—19 / 15—24）人口	估服務需求 量	● 已抓新北（16—65 女性）、桃園（含 16—19）；全齡分層待戶政司細表
醫療供給	各區婦產科診所 / 院所數	找「婦產科 稀缺區」	✓ 已抓新北桃園（健保特約，含醫院婦產科）
藥事供給	各區社區藥局數	估藥師量 能、醫藥比	✓ 已抓新北桃園
健康指標	未成年（15—19）生育率	偏鄉 / 高需求區辨識	✓ 已抓全國分縣市
校園	高中職 / 大專校院分布與在學人數	「校園周邊」 遴選	● 待補（教育部統計）
夜間醫療	夜間 / 假日婦產科可及性	「都會夜間 醫療不足區」	● 待補（健保特約看診時段可推估，本案藥局 / 婦產科檔含時段欄可再解析）
偏鄉	無婦產科鄉鎮清單	偏鄉可近性 落差	● 全台 159 鄉鎮無婦產科醫師（待縣市對照）

面向	指標	用途	取得狀態
城市分級	都會—偏鄉劃分定義	分層比較、對照組	✅ 已界定（詳「二、」；採劉介宇 7 級 + 健保醫療資源不足地區）

四、已抓數據

(1) 新北市各區：社區藥局 / 婦產科 / 16—65 歲女性人口

〔健保署特約機構名冊（依地址歸區） + 新北市民政局女性人口；2026〕

區	藥局	婦產科	16—65女性	區	藥局	婦產科	16—65女性
板橋	272	21	190,602	林口	60	2	49,026
新莊	218	15	151,527	三峽	54	0	40,772
中和	208	6	141,704	五股	34	0	34,771
三重	205	15	134,540	鶯歌	29	1	31,806
新店	109	5	107,509	泰山	25	2	28,055
土城	121	8	88,099	八里	13	0	15,845
汐止	71	4	78,423	瑞芳	22	0	11,686
淡水	71	4	77,289	（深坑、三芝、金山、萬里、貢寮、石門、烏來、石碇、雙溪、坪林、平溪）	多為0—8	0	各<8,400
蘆洲	100	7	71,871				
永和	125	10	71,118				
樹林	72	6	62,457	新北合計	1,833	106	—

(2) 桃園市各區：社區藥局 / 婦產科 / 16—65 歲女性 / 16—19 青少年

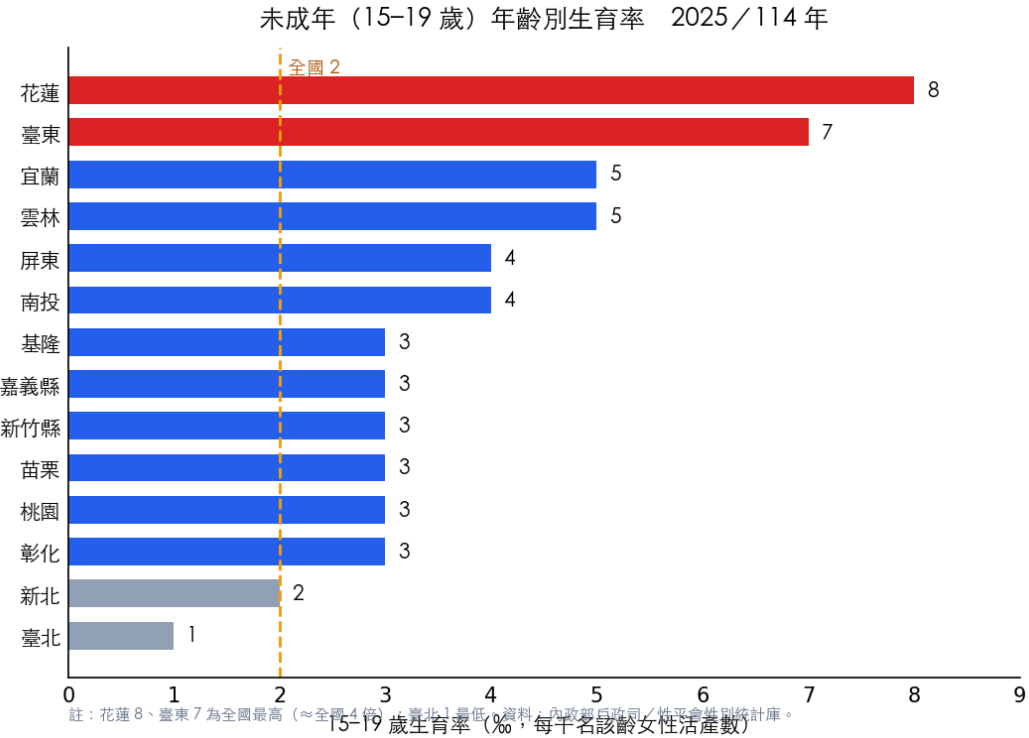
〔健保署特約機構名冊 + 桃園市 115/03 女性年齡人口〕

區	藥局	婦產科	16—65女性	16—19青少年
桃園	251	24	173,755	8,588

區	藥局	婦產科	16—65女性	16—19青少年
中壢	223	11	156,733	7,551
平鎮	78	0	79,638	4,204
八德	93	3	75,808	3,770
龜山	91	2	68,441	2,967
楊梅	70	1	65,047	3,310
蘆竹	86	2	62,467	3,539
龍潭	49	3	44,149	2,180
大園	30	2	31,996	1,560
大溪	33	1	31,431	1,576
觀音	19	0	27,206	1,385
新屋	7	0	15,829	779
復興	1	0	4,381	284
桃園合計	1,031	49	—	—

(3) 未成年（15—19）年齡別生育率（2025 / 114 年，‰）

〔內政部戶政司；性平會性別統計庫〕



花蓮 8、臺東 7‰ 為全國最高（約全國平均 2‰ 的 3—4 倍）；臺北 1‰ 最低。偏鄉高生育率集中花東，與新北、桃園之「都會婦產科稀缺區」屬不同需求類型（臺灣

省非直轄市平均 4‰)。

(4) 營業時間可近性（夜間 / 假日營業之藥局與婦產科）

〔解析健保署特約機構檔（空間分析/社區藥局-新北桃園.csv、婦產科診所_新北桃園.csv）之「固定看診時段」欄；全機構、未排除歇業，與家數口徑一致〕

為何不能只看家數：緊急避孕講求時效，藥局補位 ECP 的價值在於**部分時段（尤其週日）婦產科多休診、而社區藥局仍營業。**

市	類別	總數	平日夜間營業	週六營業	週日營業
新北	社區藥局	1,833	1,363 (74%)	1,354 (74%)	870 (47%)
新北	婦產科	106	100 (94%)	98 (92%)	15 (14%)
桃園	社區藥局	1,031	790 (77%)	782 (76%)	528 (51%)
桃園	婦產科	49	46 (94%)	48 (98%)	13 (27%)

關鍵——藥局的時間可近性優勢集中在「週日」：

- **週日：**藥局約 47—51% 營業、婦產科僅 14—27%（藥局約婦產科 2—3 倍）——藥局補位最明確的時段缺口，與專案空間分析「藥局週日約 49% vs 婦產科約 18%」一致。
- **平日夜間、週六：**婦產科診所覆蓋其實不低（夜間 94%、週六 92%+），與藥局相當或更高——此二時段藥局相對優勢有限。
- **但書：**時段僅到「上午 / 下午 / 晚上」粒度、無法區分深夜 / 凌晨；未排除歇業（與家數口徑一致）。

五、初步觀察（供遴選參考）

1. **醫藥比懸殊：**新北婦產科:藥局 $\approx$ 1:17、桃園 $\approx$ 1:21，藥師量能遠大於婦產科——支持「藥局補充取藥量能」之前提。
2. **婦產科稀缺區（高人口卻 0—2 家婦產科）= 聚焦候選：**
 - 桃園 平鎮（女 8.0 萬、婦產科 0）最突出；觀音、新屋（0）；楊梅、龜山、蘆竹、大園（高人口、1—2 家）。
 - 新北 三峽（女 4.1 萬、0）、五股（0）、林口（女 4.9 萬、僅 2）、鶯歌、泰山。
3. **時間可近性——藥局週日補位最明確：**週日藥局約 47—51% 營業 vs 婦產科 14—27%（見 (4)）；平日夜間與週六婦產科覆蓋不低，藥局優勢主要在週日。
4. **偏鄉高生育率在花蓮（花蓮 8、臺東 7‰），與新北桃園之「都會婦產科稀缺區」屬不同類型，若採城鄉分層比較宜分開設計。**

六、仍待補資料（建議第 4 場前或當場確認）

1. 校園分布（高中職 / 大專，教育部統計）——對應「校園周邊」遴選。
2. 各區營業時間細表（本檔 (4) 已算縣市層級；逐區夜間 / 週日營業家數可再由時段欄解析）。
3. 無婦產科鄉鎮清單（全台 159 鄉鎮，縣市對照）。
4. 若擴及其他縣市試辦，需比照取得各該縣市之上述資料。
5. 待索取之原始定義：①疾管署抗生素風險評估計畫「六都 vs 四級城市」分組原始依據；②主計總處都會區「統計地區標準分類」停用之原始公告；③健保署「醫療資源不足地區」門檻（每醫師 2,600 人）方案原文。

七、資料來源

官方 (✓)

- 健保署：全民健保特約醫事機構名冊（社區藥局、婦產科；依地址歸區、未排除歇業，僅供初步盤點）；「醫療資源不足地區」名單（逐年公告、現行維護）；IDS 山地離島醫療給付效益提昇計畫適用鄉鎮名單。名冊之**固定看診時段**欄供 (4) 營業時間分析。
- 內政部戶政司 / 行政院性別平等會性別統計資料庫：未成年（15—19）年齡別生育率（2025 / 114 年）。
- 新北市民政局 / 桃園市民政局：女性年齡別人口（新北 16—65；桃園含 16—19，115/03）。
- 國發會：地方創生 134 鄉鎮名單。
- 教育部：《偏遠地區學校教育發展條例》偏遠地區學校三級（偏遠 / 特殊偏遠 / 極度偏遠）。
- 行政院主計總處：都會區定義（中心都市 + 衛星市鎮、人口 ≥ 30 萬；「統計地區標準分類」已於 2010 停用、無持續維護名單）。

學術 (📖)

- 劉介宇、洪永泰、莊義利、陳怡如、翁文舜、劉季鑫、梁廣義（2006）。〈鄉鎮市區「都市化程度」7 級分類〉。《健康管理學刊》4(1):1—22。

二手 / 統計 (📊)

- 「無醫鄉」（西醫師 0 之鄉鎮）：醫師公會統計（非法定定義）。
- 全台 159 鄉鎮無婦產科醫師：依健保署婦產科特約機構分布統計。

⚠ 查無 / 待取得原始來源

- 疾管署抗生素風險評估計畫「六都 vs 四級城市」內部分組之原始依據（查無公開來源，待向疾管署 / 張文靜索取）。
- 主計總處都會區「統計地區標準分類」停用之原始公告（未取得）。
- 健保署「每醫師 2,600 人」醫療資源不足門檻方案原文（待取得）。